PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POÁ - SP
PRONTO ATENDIMENTO DR GUIDO GUIDA
RUA BARÃO DE JUPARANÃ, 43 JARDIM MEDINA - POÁ - SP, CEP:08556230
TEL: (11) 4636-8191

ALPHA INSTITUTO

PRONTUÁRIO ELETRÔNICO

SEM FOTO

UNIDADE DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO DR GUIDO GUIDA
ESPECIALIDADE: 225150 - EMERGÊNCIA/REPOUSO
DATA / HORA: 13/01/2026 01:58
PROTOCOLO: 2026GPAT/005391
NOME COMPLETO: JOSE GABRIEL MOREIRA DOS ANJOS
Nº PRONTUÁRIO: N/I
CNS: 708107564558139
DATA NASCIMENTO: 25/11/2005 (20 ANOS)
RAÇA / COR: 01 - BRANCA
SEXO: MASCULINO
NOME COMPLETO DA MÃE: ELIANA COSTA DOS ANJOS
NOME COMPLETO DO PAI: DIOMAR MOREIRA DA SILVA
RG: 53.466.616-4
CPF: 491.856.468-22
EMAIL: N/I
TELEFONE RESIDENCIAL: N/I
TELEFONE CELULAR: 11961618988
TELEFONE RECADO: N/I
CEP: 08552320
MUNICÍPIO - UF: POÁ - SP
BAIRRO: JARDIM PERRACINI
TIPO DE LOGRADOURO: RUA
NOME DO LOGRADOURO: GUARARAPES
NÚMERO: 59
COMPLEMENTO: N/I
PONTO DE REFERÊNCIA: N/I
MICROÁREA: N/I
PRIORIDADE: 1 - NORMAL
INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE O ATENDIMENTO: N/I
TIPO DE ENCERRAMENTO: N/I
CHEGADA NA UNIDADE: MEIOS PRÓPRIOS
MOTIVO DA PROCURA: N/I
OBSERVAÇÕES SOBRE ENCERRAMENTO: N/I
SITUAÇÕES ESPECIAIS: SOLICITAÇÃO DE VAGA / CROSS
OBSERVAÇÕES SITUAÇÕES ESPECIAIS:
13/01/2026 16:30:27 - PAD - EDSON DONIZETE SOARES
ACIENTE DIABETICO TIPO 1 INSULINODEPENDENTE DA ENTRADA NA EMERGENCIA INCONSCIENTE COM ESPASMOS MUSCULARES, MIOFASCICULAÇÕES, AGITAÇÃO PSICOMOTORA , DEXTRO <30 , GENITORA RELATA QUE O MESMO FOI AO BANHEIRO POR VOLTA DAS 00:00H E AS 01:30 SENTIU FALTA DO MESMO FOI QUANDO O ENCONTROU CAIDO NO BANHEIRO. HPP: DM TIPO II MUC: INSULINA NPH HD: ENCEFALOPATIA HIPOGLICEMICA / TCE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / TRIAGEM

QUEIXA: N/I
SINDROME GRIPAL: NÃO
HISTÓRICO

DATA	PROFISSIONAL	P.A. MAX	P.A. MIN	TEMPERATURA	SATURAÇÃO	F.C.	F.R.	D.X.

ALERGIAS: NEGA
MEDICAÇÃO CONTÍNUA: GLARGINA INSULINA RAPIDA
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO: 1 - EMERGÊNCIA
OBSERVAÇÕES DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO / TRIAGEM: N/I
ANTECEDENTES PESSOAIS: DM

INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO

ANAMNESE

DR. EVERALDO CAVALCANTE GOMES(247999) - 13/01/2026 03:01

DM 1

EXAME FÍSICO

DR. EVERALDO CAVALCANTE GOMES(247999) - 13/01/2026 03:01

PACIENTE DA ENTRADA APÓS TER SIDO ENCONTRADO CAIDO NO BANHEIRO APÓS HIPOGLICEMIA , TEMPO DE APROXIMADAMENTE 60 MINUTOS , NA CHEGADA APRESENTAVA ESPASMOS MUSCULARES , AGITAÇÃO , TAQUICARDIA. CORRIGIDO A GLICEMIA E SENDO NECESSARIO DIAZEPAM + MIDAZOLAM PARA ESTABILIZAÇÃO

CID 10 I

G934 - ENCEFALOPATIA NÃO ESPECIFICADA

CID 10 II

S00 - TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA CABECA

CID 10 III

E162 - HIPOGLICEMIA NÃO ESPECIFICADA

CONDUTA

DR. EVERALDO CAVALCANTE GOMES(247999) - 13/01/2026 03:01

SUPLEMENTAÇÃO DE GLICOSE, MONITORIZAÇÃO + EXAMES LAB

PROCEDIMENTO(S) EXECUTADO(S)

0214010015 - GLICEMIA CAPILAR
0214010163 - SWAB-ANTÍGENO COVID-19
0301010048 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)
0301010170 - CONSULTA/AVALIAÇÃO EM PACIENTE INTERNADO
0301060061 - ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA
0301100039 - AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL

HISTÓRICO MEDICAÇÃO / PROCEDIMENTO (INTERNO)

EMISSÃO	EMISSOR	MEDICAÇÃO / PROCEDIMENTO	REGISTRO DE PROCEDIMENTO / INTERCORRÊNCIAS	STATUS
13/01/2026 15:16	ENF. CLEBER DE CARVALHO	0214010163 - SWAB-ANTÍGENO COVID-19	RESULTADO: **NÃO DETECTADO**	EXECUTADO - 13/01/2026 15:16

HISTÓRICO SOLICITAÇÕES

DATA	SOLICITANTE	SOLICITAÇÕES
14/01/2026 05:07	DR. EDSON DONIZETE SOARES	0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA / 0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO / 0202010635 - DOSAGEM DE SODIO / 0202010694 - DOSAGEM DE UREIA / 0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO / 0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA / 0211080020 - GASOMETRIA VENOSA
13/01/2026 16:31	DR. EDSON DONIZETE SOARES	0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO (SEM CONTRASTE)
13/01/2026 10:51	DR. EDSON DONIZETE SOARES	0202050017 - ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (URINA I)
13/01/2026 03:14	DR. EVERALDO CAVALCANTE GOMES	0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO / 0202010317 - DOSAGEM DE CREATININA / 0202010562 - DOSAGEM DE MAGNESIO / 0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO / 0202010635 - DOSAGEM DE SODIO / 0202010694 - DOSAGEM DE UREIA / 0202020380 - HEMOGRAMA COMPLETO
13/01/2026 03:01	DR. EVERALDO CAVALCANTE GOMES	0202010732 - GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)

RECEITUÁRIO(S)

RECEITUÁRIO(S) ESPECIAL(AIS)

CID10 - N/I

DIAZEPAM 10MG --- 2 AMPOLAS

CID10 - N/I

MIDAZOLAM 50MG --- 1 AMPOLA

CID10 - N/I

MIDAZOLAM 50MG --- 3 AMPOLAS

CID10 - N/I

USO IM

1) MIDAZOLAM 5MG/ML ---- 10 ML ----- 1 AMPOLA

FAZER 3ML IM AGORA E ACM

CID10 - N/I

USO IM

1) CLORPROMAZINA 5MG/ML - 5ML - 1 AMPOLA

FAZER IM AGORA

CID10 - N/I

USO IM

- HALOPERIDOL 5MG/ML - 1 AMPOLA

FAZER IM AGORA

CID10 - N/I

USO EV

1) PROPOFOL 10MG/ML - 20ML - 1 AMPOLA

FAZER EV ACM

EVOLUÇÃO MÉDICA

EDSON.SOARES - 14/01/2026 05:07

EVOLUI COM MELHORA NO NIVEL DE CONSCIENCIA, MANTENDO DIALOGO E RESPONDENDO QUESTÕES DE FORMA ADEQUADA, ECG 15 (AO 4 MRM 6 MRV 5), PIFR SEM DEFICITS MOTORES EVIDENTES.

CT DE CRÂNIO SEM CONTRASTE SEM ALTERAÇÕES

EDSON.SOARES - 13/01/2026 10:44

HD: HIPOGLICEMIA
ENCEFALOPATIA HIPOGLICEMICA?

HPMA: PACIENTE DIABETICO TIPO 1 INSULINODEPENDENTE DA ENTRADA NA EMERGENCIA INCONSCIENTE COM ESPASMOS MUSCULARES, MIOFASCICULAÇÕES, AGITAÇÃO PSICOMOTORA , DEXTRO <30 , GENITORA RELATA QUE O MESMO FOI AO BANHEIRO POR VOLTA DAS 00:00H E AS 01:30 SENTIU FALTA DO MESMO FOI QUANDO O ENCONTROU CAIDO NO BANHEIRO.

HPP: DM TIPO II

MUC: INSULINA NPH

EXAME FISICO
REG, HIDRATADO, ANICTERICO, ACIANOTICO, AGITADO E CONFUSO
AR: MVC BILATERALMENTE
AVC: BRNF EM 2T S/S
ABDOME: PLANO, RHA (+) , CICATRIZ ABDOMINAL DEVIDO LAPARO POR APENDICITE SUPURADA
EXTREMIDADES: LIVRES DE EDEMAS, PULSOS PALPAVEIS
NRL: ECG 14 PIFR SEM DEFICITS MOTORES

EXAMES: 13/01/2025 - HB 13,9 / HT 40,3 / LEUCO 21400 / PW 313000 / GASOMETRIA PH 7,29 / PCO2 44 / PO2 103 / BIC 21 / SAT97 / UREIA 39 / CR 1,6 / NA 139 / K 4,7 / CA 10,9 / MG 2,1 /

EVOLUÇÃO: PACIENTE EM LEITO DE EMERGENCIA DEVIDO HIPOGLICEMIA E AGITAÇÃO PSICOMOTORA MESMO AOS CONTROLE DA HIPOGLICEMIA, MANTENHO EM OBSERVAÇAÕ NEUROLOGICA, CASO NÃO HAJA MELHORA SOLICITO CT DE CRANIO SEM CONTRASTE.

CD:

- OBSERVAÇÃO NEUROLOGICA
- CONTROLE GLICEMICO
- LIBERO DIETA

EVERALDO.GOMES - 13/01/2026 03:52

HD: HIPOGLICEMIA

HPMA: PACIENTE DIABETICO TIPO 1 INSULINODEPENDENTE DA ENTRADA NA EMERGENCIA INCONSCIENTE COM ESPASMOS MUSCULARES, MIOFASCICULAÇÕES, AGITAÇÃO PSICOMOTORA , DEXTRO <30 , GENITORA RELATA QUE O MESMO FOI AO BANHEIRO POR VOLTA DAS 00:00H E AS 01:30 SENTIU FALTA DO MESMO FOI QUANDO O ENCONTROU CAIDO NO BANHEIRO.

HPP: DM TIPO II

MUC: INSULINA NPH

EXAME FISICO
REG, HIDRATADO, ANICTERICO, ACIANOTICO, FAZENDO ESPASMOS REFRATARIO A BENZODIAZEPINICOS
AR: MVC BILATERALMENTE
AVC: BRNF EM 2T S/S
ABDOME: PLANO, RHA (+) , CICATRIZ ABDOMINAL DEVIDO LAPARO POR APENDICITE SUPURADA
EXTREMIDADES: LIVRES DE EDEMAS, PULSOS PALPAVEIS

EXAMES LAB: EM ANDAMENTO

CD:

-SUPORTE CLINICO INTENSIVO
-SUPLEMENTAÇÃO DE GLICOSE
-VIGILANCIA NEUROLOGICA/RESPIRATORIA
-SOLICITO EXAMES LAB/GASO
-AGUARDO EXAMES PARA DESFECHO

PRESCRIÇÃO

PROFISSIONAL: EDSON.SOARES **DATA/HORA:** 13/01/2026 18:08:02

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
1	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML **QTD(1)**	EV	ACM	
2	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML **QTD(1)**	IM	AGORA	
3	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML **QTD(1)**	IM	ACM	
4	SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 1.000ML[1 UNIDADE; SOL. INJETÁVEL/UNIDADE] **QTD(1)**	EV	ACM	

PROFISSIONAL: EDSON.SOARES **DATA/HORA:** 13/01/2026 10:48:20

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
1	DIETA LEVE			
2	C. C. GERAIS			ACESSO VENOSO
3	GLICOSE 50% 10ML **QTD(4)**	EV	ACM	SE GLICEMIA MENOR QUE 70MG/DL
4	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML **QTD(1)**	IM	ACM	FAZER 3 ML IM AGORA E ACM
5	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML **QTD(1)**	EV	ACM	
6	SORO GLICOSADO 500ML **QTD(1)**	EV	ACM	
7	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML 2ML **QTD(1)**	EV	SN	SE DOR OU FEBRE
8	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML **QTD(1)**	EV	SN	SE NAUSEAS OU VOMITOS
9	GLICEMIA CAPILAR		04/04H	

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
10	PA, PULSO, TEMPERATURA			

PROFISSIONAL: EVERALDO.GOMES **DATA/HORA:** 13/01/2026 05:04:33

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
2	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML **QTD(3)**	EV	ACM	DILUIR EM SF 0.9% 120 ML E CORRER ACM

PROFISSIONAL: EVERALDO.GOMES **DATA/HORA:** 13/01/2026 03:13:06

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
1	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML **QTD(3)**	EV	AGORA	DILUIR EM SG 5% 120 ML E CORRER ACM

PROFISSIONAL: EVERALDO.GOMES **DATA/HORA:** 13/01/2026 03:03:55

SEQ	PRESCRIÇÃO	VIA	INTERVALO	OBSERVAÇÕES
1	GLICOSE 50% 10ML **QTD(10)**	EV	AGORA	
2	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML **QTD(1)**	EV	AGORA	
3	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML **QTD(2)**	EV	AGORA	
4	SORO GLICOSADO 500ML **QTD(1)**	EV	AGORA	

EXAME FÍSICO

YOLANDA.CARVALHO - 14/01/2026 05:48

ESTADO NUTRICIONAL: NORMAL | **BOCA / DENTIÇÃO:** HIDRATADA | **AUSCULTA CARDÍACA:** RÍTMICO | , NORMOFONÉTICAS , 2T **TÓRAX:** SIMÉTRICOS | **EVACUAÇÃO:** AUSENTE | **RESPIRAÇÃO:** EUPNEICO | **MUCOSA:** HIDRATADA | **ABDOME:** GLOBOSO | , FLÁCIDO , INDOLOR **GENITURINÁRIO:** SEM ALTERAÇÕES | , USO DE FRALDA **GENITURINÁRIO - MICÇÃO:** ESPONTÂNEA | **MEMBROS SUPERIORES:** SEM ALTERAÇÃO | **MEMBROS SUPERIORES - PULSO PALPÁVEL:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS SUPERIORES - FORÇA PRESERVADA:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS INFERIORES:** SEM ALTERAÇÃO | **MEMBROS INFERIORES - PULSO PALPÁVEL:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS INFERIORES - FORÇA PRESERVADA:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS SUPERIORES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** AVP | - MSD

CLEBER.CARVALHO - 13/01/2026 07:19

ESTADO NUTRICIONAL: NORMAL | **BOCA / DENTIÇÃO:** HIDRATADA | **AUSCULTA CARDÍACA:** RÍTMICO | , NORMOFONÉTICAS , 2T **TÓRAX:** SIMÉTRICOS | **EVACUAÇÃO:** AUSENTE | **RESPIRAÇÃO:** EUPNEICO | **MUCOSA:** HIDRATADA | **ABDOME:** GLOBOSO | , FLÁCIDO , INDOLOR **GENITURINÁRIO:** SEM ALTERAÇÕES | , USO DE FRALDA **GENITURINÁRIO - MICÇÃO:** ESPONTÂNEA | **MEMBROS SUPERIORES:** SEM ALTERAÇÃO | **MEMBROS SUPERIORES - PULSO PALPÁVEL:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS SUPERIORES - FORÇA PRESERVADA:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS INFERIORES:** SEM ALTERAÇÃO | **MEMBROS INFERIORES - FORÇA PRESERVADA:** DIREITO | , ESQUERDO **MEMBROS SUPERIORES - INFORMAÇÕES ADICIONAIS:** AVP |

DIAGNÓSTICO/PRESCRIÇÃO ENFERMAGEM

YOLANDA.CARVALHO - 14/01/2026 05:48

DIAGNÓSTICO

RISCO DE QUEDA / HISTÓRICO DE QUEDA
RISCO DE QUEDA / MEDICAMENTO
NÁUSEAS / RELACIONA A DOR
RISCO PARA INFECÇÃO / EXPOSIÇÃO AMBIENTAL AUMENTADA PARA PATÓGENOS
RISCO PARA INFECÇÃO / PROCEDIMENTOS
RISCO PARA CONSTIPAÇÃO / MUDANÇAS DE PADRÕES HABITUAIS E ALIMENTARES
INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA / PROCEDIMENTOS
PERFUSÃO TISSULAR ALTERADA
CONFORTO ALTERADO
ANSIEDADE

PRESCRIÇÃO / APRAZAMENTO

ANOTAR E COMUNICAR QUEIXAS DE CEFALEIA, ESCOTOMA, EPIGASTRALGIA (HIPERTENSÃO) / N M T
AUXILIAR E REALIZAR O BANHO / N M T
MANTER CABECEIRA ELEVADA / MANTER
MANTER GRADES ELEVADAS / MANTER
OBSERVAR E COMUNICAR ALTERAÇÃO DA INTEGRIDADE DA PELE / N M T
QUEIXAS DE SUDORESE, TREMORES, CALAFRIOS (DIABÉTICAS) / ATENÇÃO
REALIZAR A RETIRADA DE DISPOSITIVOS INVASIVOS QUANDO NÃO MAIS NECESSÁRIOS (AVP E CVD) / S/N

CLEBER.CARVALHO - 13/01/2026 07:19

DIAGNÓSTICO

RISCO DE QUEDA / HISTÓRICO DE QUEDA
RISCO DE QUEDA / MEDICAMENTO
NÁUSEAS / RELACIONA A DOR
RISCO PARA INFECÇÃO / EXPOSIÇÃO AMBIENTAL AUMENTADA PARA PATÓGENOS
RISCO PARA INFECÇÃO / PROCEDIMENTOS
RISCO PARA CONSTIPAÇÃO / MUDANÇAS DE PADRÕES HABITUAIS E ALIMENTARES
INTEGRIDADE DA PELE PREJUDICADA / PROCEDIMENTOS
PERFUSÃO TISSULAR ALTERADA
CONFORTO ALTERADO
ANSIEDADE

PRESCRIÇÃO / APRAZAMENTO

ANOTAR E COMUNICAR QUEIXAS DE CEFALEIA, ESCOTOMA, EPIGASTRALGIA (HIPERTENSÃO) / M T N
AUXILIAR E REALIZAR O BANHO / M T N
MANTER CABECEIRA ELEVADA / M T N
MANTER GRADES ELEVADAS / M T N
OBSERVAR E COMUNICAR ALTERAÇÃO DA INTEGRIDADE DA PELE / M T N

QUEIXAS DE SUDORESE, TREMORES, CALAFRIOS (DIABÉTICAS) / M T N
REALIZAR A RETIRADA DE DISPOSITIVOS INVASIVOS QUANDO NÃO MAIS NECESSÁRIOS (AVP E CVD) / S/N

EVOLUÇÃO ENFERMAGEM

YOLANDA.CARVALHO - 14/01/2026 03:17

19:00 RECEBO O PLANTÃO COM PACIENTE ACOMODADO EM LEITO 02 DA EMERGENCIA, CAMA COM GRADES E DECUBITO ELEVADOS E RODAS TRAVADAS. MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMETROS E OXIMETRIA DE PULSO. HD: HIPOGLICEMIA. AO EXAME FISICO: DORMINDO, ARRESPONSIVO AOS ESTIMULOS VERBAIS E DOLOROSOS, CORADO, DESIDRATADO, ACIANOTICO, ANICTERICO, AFEBRIL, COURO CABELUDO INTEGRO, PUPILAS ISOFOTORREAGENTES, CAVIDADE ORAL E NASAL INTEGRAS, AP: EUPNEICO EM AA, SATURANDO 95%, MV+ SEM RA. AC: BCRNF EM 2T SS. MMSS: SEM EDEMA, MANTEM AVP EM MSD DATADO E IDENTIFICADO SEM SINAIS FLOGISTICOS APARENTE. AB: PLANO FLACIDO INDOLOR A PALPAÇÃO. GENITURINARIO: DIURESE EXPONTANEA COM AUXILIO DE FRALDA. MMII: SEM EDEMA, MANTEM FORÇA MOTORA PRESERVADA. MANTEM CONTENÇÃO MECANICA PARA SUA PROPRIA SEGURANÇA.
22:10 ENCAMINHADO PACIENTE EM MACA PARA REALIZAÇÃO TC DE CRANIO EM HOSPITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, SEGUE ACOMPANHADA POR TECNICA DE ENFERMAGEM (DEBORA), DRA. MAYARA, E CONDUTOR TOM.
23:20 PACIENTE RETORNA EM MACA APÓS REALIZAÇÃO DA TC DE CRANIO, ACOMODADO PACIENTE EM REPOUSO NO LEITO NOVAMENTE, CABECEIRA E GRADES ELEVADAS, CAMA BAIXA E RODAS TRAVADAS, VERIFICADO SINAIS VITAIS, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.
02:30 PACIENTE ACORDADO, COMUNICATIVO. ENCAMINHADO AO BANHEIRO SEM INTERCORRENCIAS. ACOMODADO EM LEITO SEM QUEIXAS.
05:20 COLETADO EXAMES LABORATORIAIS E ENCAMINHADO AO LABORATORIO.
07:00 PASSO O PLANTÃO PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM DIURNO SEM INTERCORRENCIAS.

CLEBER.CARVALHO - 13/01/2026 07:21

TEMPERATURA: 37,0 **FREQUÊNCIA CARDÍACA:** 119 **FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA:** 16 **GLICEMIA CAPILAR(DX):** 220 **PA. MÁXIMA:** 148 **PA. MÍNIMA:** 95

07:00 RECEBO PLANTÃO COM PACIENTE EM CHOQUE 02 DA EMERGENCIA COM GRADES E RODAS TRAVADAS E DECUBITOS ELEVADOS EM CONTENÇÃO MECANICA PARA SUA SEGURANÇA O MESMO DORMINDO RESPONDE A ESTIMULOS DOLOROSOS RECEBENDO MIDAZOLAM EM BIC 4 ML / H
08:00 DR EDSON AVALIA E SOLICITA 3 ML DE MIDAZOLAM IM 1 AMP DE PROMETAZINA IM VERBALMENTE
11:15 PACIENTE APRESENTA AGITAÇÃO DR EDSON AVALIA E SOLICITA VERBALMENTE 1 AMP DE HALOPERIDOL
13:00 DR EDSON AVALIA E REFERE 1 AMP DE CLOMPROMAZINA IM
15:00 PACIENTE APRESENTA DEXTRO DE 578 COMUNICADO DR EDSON QUE SOLICITA VERBALMENTE 14 U DE INSULINA REGULAR
15:30 PUNCIONADO EM MSD J18 PELA TEC ANA PAULA
15:30 REALIZADO TESTE DE COVID COM RESULTADO NEGATIVO REALIZADO E-SUS
15:40 PACIENTE ACOMODADO EM LEITO 02 COM GRADES E RODAS TRAVADAS E CONTENÇÃO MECANICA PARA SUA SEGURANÇA
16:00 PACIENTE RECEBE VISITA DE FAMILIAR
16:20 DR EDSON AVALIA PACIENTE E CONVERSA COM FAMILIAR E REFERE SOLICITAR TC DE CRANIO PARA PACIENTE
19:00 PASSO PLANTÃO

POLIANA.ALVES - 13/01/2026 04:49

TEMPERATURA: 36,5 **FREQUÊNCIA CARDÍACA:** 106 **FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA:** 30 **GLICEMIA CAPILAR(DX):** 73 **PA. MÁXIMA:** 146 **PA. MÍNIMA:** 85

02:02 RECEBO PACIENTE NO LEITO DE CHOQUE 02, TRAZIDO NA MACA PELO ENFERMEIRO EDGAR, HD. HIPOGLICEMIA. AO EXAM FISICO PACIENTE INCONSCIENTE, APRESENTA ESPASMOS MUSCULARES, AGITAÇÃO PSICOMOTORA, COM DX LO SAT 88 EM AA, CICATRIZ EM REGIÃO FRONTAL D, CICATRIZ EM REGIÃO HIPOGÁSTRICA. MÃE REFEQUE QUE PACIENTE DESMAIOU NO BANHEIRO. PACIENTE DIABÉTICO TIPO I, INSULINODEPENDENTE.
02:04 REALIZADO RESGATE COM 4 AMP DE GLICOSE A 50%. INSTALADO CN DE O2 A 6L/MIN E MONITORIZAÇÃO MULTI PARAMETROS. AVALIADO PELO DR. EVERALDO, ADMINISTRADO 2 AMP DE DIAZEPAM.
02:10 PUNCIONADO JD J18 PELO ENFERMEIRO EDGAR.
02:25 PACIENTE MANTÉM QUADRO DE AGITAÇÃO, ADMINISTRADO 3 AMP DE MIDAZOLAN EM BIC 6ML/H CORRENDO EM AVP JD J18.
04:10 PACIENTE APRESENTA DX DE 36, REALIZADO NOVO RESGATE COM 8 AMPOLA DE GLICOSE 50% E INSTALADO SG 0,5% + 8AMP DE GLICOSE 25%.
05:25 SOLICITO TESTE DE COVID E COLETA DE RTPCR, REALIZO NOT.
07:00 PASSO PLANTÃO COM PACIENTE NO LEITO DE EMERGENCIA, APRESENTANDO QUADROS DE AGITAÇÃO, EM USO DE MIDAZOLAN EM BIC. MANTENDO MONITORAMENTO MULTI PARAMETROS.

ANOTAÇÕES ENFERMAGEM

EMERSON.NEVES - 13/01/2026 19:39

19:00 RECEBO PLANTÃO, ENCONTRO PACIENTE EM REPOUSO NO LEITO SEM QUEIXAS, CABECEIRA E GRADES ELEVADAS, CAMA BAIXA E RODAS TRAVADAS, ACORDADO, CONTACTUANTE, AGITADO COM PERIODOS DE AGRESSIVIDADE, EM AR AMBIENTE, NEGA ALERGIA, MANTENDO MONITOR MULTIPARAMETROS, CONTENÇÃO MECANICA EM MMSS E MMII, AVP EM MSD JELCO 18- FIXADO E DATADO EM 13/01/2026 SEGUE SALINIZADO SEM SINAIS FLOGISTICOS, PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PRESENTE E LEGIVEL, IDENTIFICAÇÃO BEIRA LEITO PRESENTE E LEGIVEL, FAZ USO DE FRALDAS, REFERE DIURESE + EVACUAÇÃO PRESENTE E LEGIVEL NA DATA DE HOJE 13/01/2026, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO COM PERIODOS DE AGITAÇÃO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

20:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, FRALDA SEGUE LIMPA E SECA, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

21:00 FRALDA SEGUE LIMPA E SECA, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO COM PERIODOS DE AGITAÇÃO E AGINDO DE FORMA RISPIDA, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

22:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, REALIZADO TROCA DE FRALDA + ROUPAS INTIMAS, DIURESE PRESENTE EM GRANDE QUANTIDADE, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

22:10 ENCAMINHADO PACIENTE EM MACA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS, SEGUE ACOMPANHADA POR TECNICA DE ENFERMAGEM (DEBORA), DR. MAYARA, E EQUIPE DE TRASNPORTE DA INSTITUIÇÃO.

23:20 PACIENTE RETORNA EM MACA APÓS REALIZAÇÃO DE EXAMES FORA DA INSTITUIÇÃO, ACOMODADO PACIENTE EM REPOUSO NO LEITO NOVAMENTE, CABECEIRA E GRADES ELEVADAS, CAMA BAIXA E RODAS TRAVADAS, VERIFICADO SINAIS VITAIS, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

00:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, REALIZADO TROCA DE FRALDA + HIGIENE INTIMA, DIURESE PRESENTE EM GRANDE QUANTIDADE, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

01:00 PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

02:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

03:00 PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

04:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, FRALDA SEGUE LIMPA E SECA, PACIENTE APRESENTA DIURESE EM GRANDE QUANTIDADE EM PAPAGAIO, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

05:00 PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, ORIENTADO SOLICITAR EQUIPE DE ENFERMAGEM SEMPRE QUE NECESSARIO.

05:30 REALIZADO COLETA DE EXAMES CPM.

06:00 VERIFICADO SINAIS VITAIS, FRALDA SEGUE LIMPA E SECA, PACIENTE SEGUE EM REPOUSO NO LEITO, SEGUE AOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

THATYANE.PRADO - 13/01/2026 16:13

16:00 RECBO PLANTAO COM PACIENTE EM LEITO 2 COM GRADES E DECUBITOS ELEVADOS, PACIENTE DORMINDO, EM A.A, MANTENDO AVP EM MSD JELCO 18, FAZAENDO USO DE FRALDA, CONTIDO EM MMSS E MMII.
16:05 AFERIDO SSVV.
16:30 DEXTRO 545MG/DL, DR EDSON SOLICITA SUPLEMENTAR PACIENTE COM 12 UI DE INSULINA REGULAR SC, CPM.
17:00 DR EDSON SOLICITA SORO FISIOLOGICO DE 500ML EV, CPM.
18:00 DR EDSON SOLICITA SORO FISIOLOGICO DE 500ML EV, CPM.
18:00 SAI VAGA CROSS PARA HOSPITAL DE FERRAZ, PARA TOMOGRAFIA.
18:30 AFERIDO SSVV.
18:35 DR EDSON SOLICITA 1000ML DE SORO FISIOLOGICO EV, CPM.
19:00 PASSO PLANTAO COM PACIENTE EM LEITO 2 COM GRADES E DECUBITOS ELEVADOS, CONTIDO EM MMSS E MMII, SEGUE AOS CUIDADOS DO TEC DO SETOR.

ANA.SILVA - 13/01/2026 12:01

07:00 RECEBO PLANTÃO COM PACIENTE EM MACA 02 DO SETOR DE EMERGENCIA ADULTA, PACIENTE APRESENTA - SE AGITADO, GRITANDO, SUDOREICO, AGRESSIVO, COM UM HEMATOMA SUBGALEAL NA REGIÃO FRONTAL (DA TESTA) DEVIDO A QUEDA QUE O MESMO TEVE EM SUA PROPRIA RESIDENCIA. EM MONITORIZAÇÃO DE MULTIPARAMETROS, MANTENDO CATETER TIPO ÓCULOS A 1 L/MIN, AVP EM MSD, JELCO 20 RECEBENDO MIDAZOLAM EM B.I.C A 6 ML/H E SOROTERAPIA, CONTINDO EM MMSS PARA SEGURANÇA DO MESMO. SEGUE AGUARDANDO REAVALIAÇÃO MÉDICA.
07:10 AFERIDO SSVV, DEXTRO NO VALOR DE 220 MG/DL, COMUNICADO DR. EDSON SOARES.
08:00 PACIENTE APRESENTA - SE MUITO AGITADO, LEVANTANDO DA MACA, FOI COLOCADO CONTENÇÃO DE TORAX E EM MMII PARA PROTEÇÃO DO MESMO, A PEDIDO DO ENFERMEIRO CLEBER.
08:30 PACIENTE MUITO AGITADO, GRITANDO, DR. EDSON SOARES SOLICITA VERBALMENTE PARA MEDICAR COM 3 ML DE MIDAZOLAM IM E 1 AMPOLA DE PROMETAZINA IM. MEDICO PACIENTE CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM VLD/VLE.
09:00 PACIENTE SEGUE NA MACA DORMINDO.
09:05 DR EDSON SOLICITA VERBALMENTE PARA MEDICAR PACIENTE COM 500 ML DE SF 0,9%.
09:30 PACIENTE AGITADO, O MESMO SACA AVP. REALIZADO DIVERSAS TENTATIVAS SEM SUCESSO, COMUNICADO ENFREMEIRO CLEBER E DR. EDSON.
10:00 AFERIDO SSVV. PACIENTE SEGUE DORMINDO.
10:30 FISIO HELLEN RETIRA CATETER DE O2, PACIENTE SEGUE SATURANDO 96% EM AR AMBIENTE
11:00 ENFERMEIRA GABRIELLE TAVARES REALIZA DUAS TENTATIVA DE ACESSO EM VEIA JUGULAR POREM SEM SUCESSO POIS PACIENTE SE MANTEM AGITADADO.
11:15 PACIENTE APRESENTA AGITAÇÃO, DR EDSON AVALIA E SOLICITA VERBALMENTE 1 AMPOLA DE HALOPERIDOL IM E 3 ML DE MIDAZOLAM IM. MEDICAÇÃO ADMINISTRADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM THATYANE EM VLD/VLE.
13:00 DR EDSON SOLICITA VERBALMENTE 1 AMPOLA DE CLOMPROMAZINA IM, MEDICAÇÃO ADMINISTRADA PELA TEC. DE ENFERMAGEM THATYANE.
14:00 PACIENTE SEGUE NO LEITO DORMINDO.
15:00 AFERIDO SSVV, DEXTRO NO VALOR DE 578 MG/DL, COMUNICADO DR. EDSON.
15:15 DR. EDSON SOLICITA VERBALMENTE PARA ADMINISTRAR 14 UI DE INSULINA REGULAR VIA SUBCUTANEA. MEDICO PACIENTE CONFORME PEDIDO MÉDICO.
15:30 REALIZADO AVP EM MSD, JELCO 18, SALINIZADO SEM SINAIS FLOGITICOS.
15:40 REALIZADO TESTE DE COVID, RESULTADO NEGATIVO, FEITO NOTIFICAÇÃO.
16:00 ENCAMINHADO PACIENTE PARA LEITO 2, PACIENTE SEGUE AOS CUIDADOS DA TEC. DE ENFERMAGEM THATHYANE.

JESSICA.DIAS - 13/01/2026 04:08

01;40 RECEBO PACIENTE EM CHOQ , TRAZIDO PELO ENFERMEIRO EDGAR , COM HIPOGLICEMIA EM (LO)
01;42 REALIZADO AVP EM MSD
01;44 COLETADO EXAMES
01;45 REALIZADO PROTOCOLO COM 4 AMPOLAS DE GLICOSE 50%
02;00 REALIZADO AVP EM JUGULAR DIREITA
02;10 REALIZADO MEDICAÇÃO CONFORME PM GLICOSE
02;15 REALIZADO MEDICAÇÃO CONFORME PM DIAZEPAM
02;17 REAIZADO MEDICAÇÃO CONFORME PM SORO GLICOSADO
02;20 REALIZADO MEDICAÇÃO CONFORME PM MIDAZOLAN
02;50 ENTRA A BOMBA DE MIDAZOLAN
03;00 COLETADO GASOMETRIA PELA ENFERMEIRA DENEIDE
03;10 AFERIDO SSVV
04;10 REALIZADO PROTOCLO DE GLICOSE DEXTRO DE 21
04;15 REALIZADO SORO GLICOSADO
05;30 REALIZADO TESTE DE COVID
06;15 REALIZADO RTPCR E PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
06;20 AFERIDO SSVV
06;25 REALIZADO SORO FISIOLOGICO
06;30 REALIZADO 2 FUROSEMIDA CONFORME DR EVERALDO PEDIU
07;00 PASSO PLANTAO SEM INTERCORRECIA, PACIENTE NO CHOQ POIS DR VAI AVALIAR

EVOLUÇÕES MULTIDISCIPLINARES

FISIOTERAPEUTA GERAL (LARISSA.MENDONCA - 13/01/2026 23:07)

HD: HIPOGLICEMIA

ENCONTRO PACIENTE NO LEITO EM DD COM GRADES E CABECEIRA SEMI ELEVADO. DORMINDO NÃO ACORDA AO CHAMADO, CONTIDO EM MMSS E MMII, NÃO COLABORATIVO E CONTACTUANTE VERBALMENTE. ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, NORMOCÁRDICO, AFEBRIL E EUPINEICO, RESPIRANDO ESPONTANEAMENTE EM AA, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.
SSVV: SAT: 99% | FC: 100 BPM | FR: 18 RPM
AP: SOM PULMONAR PRESENTE S/ RA.

CONDUTA:
- AV. RESPIRATÓRIA.
- MANTNHO EM A.A;
- SEGUE EM VIGILANCIA;
- OTIMIZO POSICIONAMENTO EM DD SEMI ELEVADO

ATENDIMENTO REALIZADO SEM INTECORRÊNCIAS

ASSISTENTE SOCIAL (VANESSA.SANTOS - 13/01/2026 16:45)

DURANTE VISITA BEIRA LEITO, ENTREGO MANUAL INFORMATIVO AO FAMILIAR PRESENTE (GENITORA) E ANEXO CONTATOS TELEFONICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO.

FISIOTERAPEUTA GERAL (HELLEN.RIBEIRO - 13/01/2026 10:35)

HD: HIPOGLICEMIA
ENCONTRO PACIENTE NO LEITO EM DD COM GRADES E CABECEIRA SEMI ELEVADO. ACORDADO, CONFUSO, NÃO COLABORATIVO E CONTACTUANTE VERBALMENTE. ACIANÓTICO, ANICTÉRICO, NORMOCÁRDICO, AFEBRIL E EUPINEICO, RESPIRANDO ESPONTANEAMENTE EM AA, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO. SOB APORTE DE CN 6L. *** PACIENTE CONTIDO EM MMSS E MMI

SSVV: SAT: 99% | FC: 105BPM | FR: 20RPM
AP: SOM PULMONAR PRESENTE S/ RA.

CONDUTA:
- AV. RESPIRATÓRIA.
- TOSSE ESTIMULADA EFICAZ.
- REALIZO DESMAME DE O2 PARA AA. (SAT ESTÁVEL 96%)
- SEGUE EM OBS

EM TEMPO
PACIENTE AGITADO E AGRESSIVO. NECESSÁRIO MANTER CONTENÇÃOE EM MMSS, MMII E TORAX.
IMPOSSIBILITADO DE DEMAIS CONDUTAS FISIOTERAPEUTICAS.
SEGUE EM OBS.

NUTRICIONISTA (THAIS.CARVALHO - 13/01/2026 08:03)

PACIENTE INTERNADO NO LEITO DA EMERGENCIA - ESTABILIZACAO.

SEGUE EM JEJUM.

NO AGUARDO PARA LIBERACAO DE DIETA.

SEGUE EM ACOMPANHAMENTO.

PLANTÃO DE 13/01/2026

		SINAIS VITAIS							RESPIRADOR						GANHOS						DROGAS VASOATIVAS			DIETA		PERDAS						
HORÁRIO	ESCALA DOR	TEMPERATURA	FREQUÊNCIA CARDÍACA	RESPIRAÇÃO	P.A.	P.V.C.	SAT.O²	GLICEMIA CAPILAR	MÓDULO	FIO2	F.R.	PRESSÃO INSP.	PEEP	FLUXO			SORO	MEDICAÇÃO	HEMO DERIVADOS	INSULINA				VIA ORAL	SNG/SNE	ASPIRAÇÃO	SNG/SNE	DRENO	DIURESE	EVACUAÇÃO	LÓQUIOS	VÔMITOS
07:10		37,6	118	17	148X95		95	220																								
09:00																																
10:00		36,8	125	17	151X100		95																									
11:00																																
12:00		36,6	112	20	152X64		96	178																								
13:00																																
14:00																																
15:00		36,7	112	20	125X64		96	578																								
16:30		36	100		130X60		97	556																								
17:00																																
18:30		36,2	118		120X70		98	345																								
19:00																																
BALANÇO PARCIAL																																
20:00		36,8	108	19	147X64		98%	183MG/DL																								
21:00																																
22:00		36,9	98	22	113X72		98%	172MG/DL																					+++++			
23:00																																
00:00		36,5	102	23	154X66		99%	168MG/DL																								
01:00																																
02:00		36,4	98	20	123X81		98%	159MG/DL																								
03:00																																
04:00		36,7	111	23	140X62		96%	153MG/DL																					+++++			
05:00																																
06:00																																
07:00																																
BALANÇO PARCIAL																													0			
BALANÇO DE 24 HORAS									GANHOS:0			PERDAS:0			TOTAL:0																	

ANA.SILVA (07:10, 10:00, 12:00, 15:00)
EMERSON.NEVES (00:00, 02:00, 04:00, 20:00, 22:00)
THATYANE.PRADO (16:30, 18:30)

PLANTÃO DE 12/01/2026

		SINAIS VITAIS							RESPIRADOR						GANHOS						DROGAS VASOATIVAS			DIETA		PERDAS						
HORÁRIO	ESCALA DOR	TEMPERATURA	FREQUÊNCIA CARDÍACA	RESPIRAÇÃO	P.A.	P.V.C.	SAT.O²	GLICEMIA CAPILAR	MÓDULO	FIO2	F.R.	PRESSÃO INSP.	PEEP	FLUXO			SORO	MEDICAÇÃO	HEMO DERIVADOS	INSULINA				VIA ORAL	SNG/SNE	ASPIRAÇÃO	SNG/SNE	DRENO	DIURESE	EVACUAÇÃO	LÓQUIOS	VÔMITOS
08:00																																
09:00																																
10:00																																
11:00																																
12:00																																
13:00																																
14:00																																

PLANTÃO DE 12/01/2026

		SINAIS VITAIS							RESPIRADOR						GANHOS						DROGAS VASOATIVAS			DIETA		PERDAS						
15:00																																
16:00																																
17:00																																
18:00																																
19:00																																
BALANÇO PARCIAL																																
20:00																																
21:00																																
22:00																																
23:00																																
00:00																																
01:00																																
02:00																																
03:00		36,5	106	21	168X86		99	21																								
04:00																																
05:00																																
06:00		37,1	125	17	174X87		97	150																								
07:00																																
BALANÇO PARCIAL																																
BALANÇO DE 24 HORAS									GANHOS:0			PERDAS:0			TOTAL:0																	

JESSICA.DIAS (03:00, 06:00)